Beispieldaten: Alle Personen, Einrichtungen, Daten und Befunde sind erfunden. Kein Behandlungsstandard, kein medizinischer Rat. Vorlage von custix.ai, frei verwendbar.

Landeskrankenhaus Musterstadt
Abteilung für Innere Medizin
Spitalgasse 12, 8010 Musterstadt
innere@lkh-musterstadt.example

Dr. Peter Gruber
Facharzt für Allgemeinmedizin
Hauptplatz 3, 8010 Musterstadt

Musterstadt, 14.03.2026

Arztbrief: Maria Huber, geb. 12.03.1968, SV-Nr. 1234 120368, stationärer Aufenthalt 08.03.2026 bis 14.03.2026

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten über die oben genannte Patientin, die sich vom 08.03.2026 bis 14.03.2026 in unserer stationären Behandlung befand.

Diagnosen

1. Ambulant erworbene Pneumonie, rechter Unterlappen

2. Arterielle Hypertonie, medikamentös eingestellt

Anamnese

Die Patientin stellte sich am 08.03.2026 mit seit vier Tagen bestehendem Fieber bis 39,2 °C, produktivem Husten und Belastungsdyspnoe vor. Zuweisung durch Dr. Peter Gruber. Vorerkrankungen: arterielle Hypertonie. Nikotin: nie. Allergien: keine bekannt. Wohnhaft Lindenweg 7, 8010 Musterstadt.

Befunde bei Aufnahme

Klinisch: Blutdruck 135/85 mmHg, Herzfrequenz 96/min, Sauerstoffsättigung 92 % bei Raumluft, Temperatur 38,9 °C. Auskultatorisch feinblasige Rasselgeräusche rechts basal.

Labor: CRP 148 mg/l, Leukozyten 14,2 G/l, Kreatinin 0,9 mg/dl, übrige Routineparameter unauffällig.

Röntgen-Thorax vom 08.03.2026: Infiltrat im rechten Unterlappen, kein Pleuraerguss.

Therapie und Verlauf

Kalkulierte antibiotische Therapie nach hausinternem Standard, zunächst intravenös, ab dem dritten Tag oral; Gesamtdauer sieben Tage. Sauerstoffgabe über Nasenbrille am ersten Tag.

Unter Therapie rasche Entfieberung ab dem zweiten Tag. Kontrolle am 13.03.2026: CRP 31 mg/l, Sauerstoffsättigung 97 % bei Raumluft. Die Patientin war zum Entlassungszeitpunkt beschwerdefrei und mobil.

Epikrise

Bei Maria Huber bestand eine ambulant erworbene Pneumonie des rechten Unterlappens ohne Komplikationen. Unter antibiotischer Therapie kam es zu einem raschen klinischen und laborchemischen Ansprechen. Die bekannte arterielle Hypertonie war während des Aufenthalts

stabil eingestellt.

Medikation bei Entlassung

Bisherige antihypertensive Medikation unverändert weiter.

Orale antibiotische Therapie bis einschließlich 15.03.2026.

Procedere und Empfehlungen

Klinische Kontrolle in Ihrer Ordination in etwa einer Woche.

Röntgen-Thorax-Kontrolle in sechs Wochen zur Dokumentation der Rückbildung empfohlen.

Wiedervorstellung bei erneutem Fieber, zunehmender Atemnot oder Hämoptysen.

Überprüfung des Impfstatus (Pneumokokken, Influenza) empfohlen.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Anna Steiner, Assistenzärztin
Prim. Dr. Josef Bauer, Abteilungsvorstand